TEMA 10 · Bioética, Código Deontológico, consentimiento informado y secreto profesional. Calidad en el SNS

Resumen OPE Enfermería SMS · Bloque A: Ética y bioética, Código Deontológico, consentimiento informado, eutanasia y relevancia penal del secreto · Bloque B: Calidad asistencial, EFQM, seguridad del paciente, Proyectos Zero y atención basada en valor

Siglas y leyes de este tema

Sigla o norma	Nombre completo	De qué va
CGE	Consejo General de Enfermería	Aprueba el Código Deontológico
CE	Constitución Española	Art. 16 libertad ideológica (objeción); art. 18 intimidad; art. 43 protección de la salud
Ley 41/2002	Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica	Información, consentimiento, instrucciones previas
LO 3/1986	Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública	Permite medidas obligatorias por salud pública
LO 2/2010 / LO 1/2023	Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo / su reforma de 2023	Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)
Ley 3/2009 (Murcia)	Ley de los derechos y deberes de los usuarios del sistema sanitario de la Región de Murcia	
Decreto 80/2005	Decreto murciano de instrucciones previas	Cómo se otorgan y se registran
LORE (LO 3/2021)	Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia	Prestación de ayuda para morir
CP / LECrim	Código Penal / Ley de Enjuiciamiento Criminal	Delitos contra el secreto / obligación de denunciar
EDO	Enfermedades de Declaración Obligatoria	
CEA	Comité de Ética Asistencial	
Ley 14/1986 (LGS) / Ley 2/1990 / Ley 16/2003	Ley General de Sanidad / ley murciana que crea el Servicio Murciano de Salud (SMS) / Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS)	Marco de la calidad (B1)
EFQM / REDER	*European Foundation for Quality Management* / Resultados, Enfoque, Despliegue, Evaluación y Revisión	Modelo de excelencia y su herramienta de puntuación
ISO / JCI / UNE	Organización Internacional de Normalización / *Joint Commission International* / Una Norma Española	Certificación / acreditación / normas técnicas
ENEAS / APEAS	Estudio Nacional sobre los Efectos Adversos ligados a la hospitalización / ídem en Atención Primaria	Frecuencia de eventos adversos
SiNASP	Sistema de Notificación y Aprendizaje para la Seguridad del Paciente	Notificar incidentes
AMFE	Análisis Modal de Fallos y Efectos	Gestión de riesgos proactiva
CVC / NAV / ITU / IAAS	Catéter Venoso Central / Neumonía Asociada a Ventilación mecánica / Infección del Tracto Urinario / Infecciones Asociadas a la Asistencia Sanitaria	Proyectos Zero
PROMs / PREMs	*Patient-Reported Outcome / Experience Measures*	Resultados / experiencia que cuenta el propio paciente
PDCA	*Plan, Do, Check, Act* (planificar, hacer, verificar, actuar)	Ciclo de mejora de Deming
PBE / GRADE	Práctica Basada en la Evidencia / sistema de calidad de la evidencia	B4

A1. Moral, ética, deontología y derecho

Concepto	Qué es	Sanción
Moral (*mos*: costumbre)	Normas y costumbres **prácticas** de un grupo: ¿qué debo hacer?	Reproche social o remordimiento
Ética (*ethos*: carácter)	Reflexión **filosófica, teórica** sobre la moral: ¿por qué?	Sin sanción externa
Deontología (*déon*: deber)	Deberes de una **profesión**, plasmados en un código	**Colegial / disciplinaria**
Derecho	Normas del Estado, coercitivas	**Judicial** (multa, prisión, inhabilitación)

- **Potter (1970)** acuñó "bioética" ("Bioethics: the science of survival"; "Bridge to the future", 1971).
- Hitos: **Código de Núremberg (1947)**, tras los juicios a los médicos nazis: primer reconocimiento del **consentimiento voluntario** en investigación. **Declaración de Helsinki (1964)**, Asociación Médica Mundial: **principios éticos para la investigación médica en seres humanos**. **Informe Belmont** (EE. UU., tras **Tuskegee**; redactado en 1978 y publicado en 1979): respeto a las personas, beneficencia y justicia.
- **Beauchamp y Childress (1979)**: 4 principios *prima facie* (obligan mientras no choquen con otro de más peso). **Diego Gracia**: nivel I (**mínimos**: no maleficencia y justicia) por encima del nivel II (**máximos**: autonomía y beneficencia). Truco: "**NO JU**egues con mi **AU**to **BENE**ficio".
- No maleficencia = no dañar (negativo: asepsia, dosis correctas). Beneficencia = hacer el bien (positivo: curar una úlcera, analgesia, educación para la salud).

TRAMPAS DE EXAMEN

! **Moral = práctica; ética = teoría. Núremberg = médicos nazis; Belmont = Tuskegee.**

A2. Código Deontológico y objeción de conciencia

- **Resolución 32/1989** del Consejo General de Enfermería. El manual cita un **nuevo Código Ético y Deontológico** aprobado por la Asamblea del CGE (en vigor hacia **2026**), con telemedicina, redes sociales, voluntades anticipadas, objeción de conciencia y derechos digitales.
- El colegiado incurre en responsabilidad disciplinaria por **comisión, omisión voluntaria o negligencia**.
- Artículos destacados del nuevo código según el manual: **7** (protección integral), **12** (priorizar a los **vulnerables**), **15** (modelo **deliberativo**, prohíbe el paternalismo), **25** (incapacidad de hecho; comprobar las voluntades anticipadas y, si se incumplen, elevarlo al CEA o a la gerencia), **26** (derecho a no saber), **27** (**rechazo al tratamiento**: nunca justifica el abandono ni el alta punitiva), **30-31** (registros y claves personales), **89** (dispositivos digitales: consentimiento del paciente y **autorización de la institución**), **28-29** (secreto también **tras la muerte**).
- **Objeción de conciencia** (art. 16.1 de la Constitución): el **derecho a ser eximido de cumplir un deber legal** porque va contra las propias convicciones (no es cuestionar la norma ni los valores de una organización). Es **individual** (nunca colectiva) y se manifiesta **anticipadamente y por escrito**. **No cabe en una urgencia vital** sin otro profesional disponible.

TRAMPAS DE EXAMEN

! Fotografiar una úlcera con el **móvil personal** no basta con el consentimiento verbal: hace falta autorización institucional y dispositivo corporativo.

A3. Consentimiento informado (Ley 41/2002)

- **Titular del derecho a la información (art. 5)**: el **paciente**, que también puede **renunciar** a ser informado; los familiares, en la medida en que él lo permita.
- **Art. 8**: conformidad **libre, voluntaria y consciente**, tras recibir información adecuada. Garantiza el principio de **autonomía**. **Regla general: verbal**. **Escrito** ("C.I.R."): **Cirugía**, procedimientos **Invasores** y riesgos de notoria

Repercusión negativa. **Art. 6**: derecho a la información epidemiológica.

- **Excepciones (art. 9.2)**: **riesgo para la salud pública** (Ley Orgánica 3/1986; si hay internamiento, comunicarlo al juez en **24 horas**) y **riesgo inmediato grave** para el paciente sin posibilidad de autorización.
- **Representación**: incapacidad de hecho (a criterio del médico), incapacidad legal por sentencia o menor sin madurez.

Edad	Quién consiente
< 12 años	Padres o tutores (el menor es escuchado)
12-15 años	Si es **menor maduro**, él; si no, los padres
16-17 años o emancipado	**Mayoría de edad sanitaria**: él
16-17 en grave riesgo, ensayos clínicos, reproducción asistida	**Representante legal**, oída la opinión del menor

- **IVE**: la **LO 1/2023** (modifica la LO 2/2010 de salud sexual) permite que las menores de **16 y 17 años** y las mujeres con discapacidad consientan **solas**; se suprime el consentimiento y el conocimiento de los padres y los **3 días de reflexión**. Según la **Guía de IVE 2025**, el consentimiento informado es **obligatorio** (también en el método farmacológico) y debe **adaptarse a la situación de la gestante**.
- **Garantías de la prestación de IVE (LO 2/2010, art. 19 y siguientes)**: **igual acceso** para todas las mujeres **con independencia de dónde residan**, atención adecuada antes y después de la intervención, y que la objeción de conciencia no perjudique el acceso ni la calidad. **No** incluye la libre elección de cualquier centro público.
- **Ley 3/2009 de Murcia**: información en 4 áreas (**AEPS**: asistencial, epidemiológica, planes, sistema sanitario); libre elección de médico, enfermera y centro (arts. 43-47). Ante objeción o dudas sobre unas instrucciones previas, se consulta al **CEA** del centro.
- **Instrucciones previas**: documento de una persona **mayor de edad, capaz y libre** sobre sus cuidados y tratamiento futuros o, tras morir, sobre el destino de su cuerpo u órganos (art. 11 Ley 41/2002). En Murcia (**Decreto 80/2005**): ante notario, 3 testigos (2 sin parentesco hasta 2.º grado ni relación patrimonial; la enfermera que le atiende no debe ser testigo) o funcionario del Registro; revocables; prevalece el más reciente.
- **Eutanasia (LORE, LO 3/2021, de 24 de marzo)**: la prestación de ayuda para morir forma parte de la **cartera común del SNS**; prima la **voluntad libre del solicitante**, desde el respeto a su dignidad y autonomía (no la decisión de los profesionales). **Requisitos (art. 5)**:
  - Nacionalidad española, residencia legal o empadronamiento **> 12 meses**; **mayor de edad**, capaz y consciente al pedirla.
  - Disponer **por escrito** de la información sobre su proceso y alternativas, **incluidos los cuidados paliativos** (que nunca se restringen por pedir la eutanasia).
  - **2 solicitudes por escrito** (u otro medio que deje constancia), **separadas al menos 15 días naturales**.
  - Enfermedad grave e incurable o padecimiento grave, crónico e imposibilitante, certificado por el médico responsable.
  - **Consentimiento informado** previo, que se incorpora a la historia clínica.
  - Si ya no es capaz, vale lo que dejó en sus **instrucciones previas**.
- **Denegación (art. 7)**: **siempre por escrito y motivada** por el médico responsable, en un máximo de **10 días naturales desde la primera solicitud**; el paciente puede reclamar en 15 días ante la Comisión de Garantía y Evaluación. **Registro de objetores** confidencial.

A4. Relevancia penal del secreto profesional

- **Intimidad** (esfera reservada; **art. 18.1 de la Constitución**), **privacidad** (entorno físico: cortinas, llamar a la puerta) y **confidencialidad** (garantía de no revelar).

Precepto del Código Penal	Conducta	Pena
Art. 197	Descubrir secretos (apoderarse, interceptar)	—
Art. 197 bis	**Acceso no autorizado** a sistemas (curiosear la historia clínica)	Prisión **6 meses a 2 años**

Precepto del Código Penal	Conducta	Pena
Art. 197.6	Con **fines lucrativos**	Mitad superior de la pena
Art. 199.1	Trabajador que revela secretos conocidos por su oficio (celador, limpieza)	Prisión **1-3 años**, multa 6-12 meses
Art. 199.2	**Profesional** que incumple su sigilo	Prisión **1-4 años**, multa 12-24 meses, **inhabilitación 2-6 años**

- Otras vías: civil (indemnización), administrativa (separación del servicio) y colegial.
- **Excepciones** (cumplimiento de un deber, **art. 20.7 CP**): mandato judicial (solo lo pedido), riesgo vital para terceros, **EDO** (LO 3/1986), delitos públicos (**art. 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal**: parte de lesiones) y consentimiento del paciente.
- **Secreto compartido**: lícito entre el equipo asistencial directo en un ámbito reservado; no en pasillos, cafetería o con ajenos al caso.

TRAMPAS DE EXAMEN

! El **mero acceso** sin relación asistencial ya es delito (art. 197 bis), aunque no se cuente a nadie.

BLOQUE B · Calidad en el Sistema Nacional de Salud

B1. Marco y dimensiones de la calidad

- Cronología: **Constitución, art. 43** (derecho a la protección de la salud); **Ley 14/1986, General de Sanidad** (crea el SNS); **Ley 2/1990** (según el manual, crea el Servicio Murciano de Salud: la **autoridad sanitaria** es la **Consejería** y la **gestión**, el **SMS**); **Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del SNS** (calidad sistémica; crea la **Agencia de Calidad del SNS**).
- **Plan de Calidad del SNS**: **6 áreas y 12 estrategias** (protección y promoción con la estrategia NAOS de nutrición y obesidad y el plan AP-21 de Atención Primaria; equidad; recursos humanos; excelencia clínica con GuíaSalud, ENEAS y seguridad; tecnologías de la información; transparencia y Banco de Datos del SNS). Según el SMS 2019, entre sus atributos están la excelencia clínica, la promoción y prevención y la equidad, pero **no** "la participación informada del paciente en las decisiones".
- **Plan de Salud de Murcia 2026-2032**: determinantes, problemas de salud, asistencia sanitaria y planificación basada en datos.

Dimensión	Definición
Científico-técnica	Usar el mejor conocimiento disponible (PBE)
Eficacia	Resultado en condiciones **ideales** (ensayo clínico)
Efectividad	Resultado en la **práctica real**
Eficiencia	Máxima efectividad con el **mínimo coste**
Accesibilidad	Facilidad para obtener la atención (barreras geográficas, organizativas, económicas, culturales)
Equidad	Según la **necesidad** ("dar más a quien más lo necesita"), no lo mismo a todos
Adecuación	Hacer solo lo indicado (evita infra y **sobretratamiento**)
Seguridad	Atención sin daños evitables
Satisfacción / experiencia	Expectativas cumplidas / vivencia de todo el recorrido asistencial

B2. Evaluación y mejora continua

- **Donabedian (1966)**: buena **estructura** → buen **proceso** → buen **resultado**. La estructura (recursos, edificios, **sistemas de registro**) se evalúa con inspecciones, licencias y acreditación; el proceso, con **auditoría clínica**; el resultado es lo más difícil de atribuir.
- Mejora continua: los errores son sobre todo fallos del sistema, no de la "manzana podrida".
- **Ciclo PDCA** (Shewhart, popularizado por **Deming**): **Plan** (planificar), **Do** (aplicar, en una **prueba piloto**), **Check** (verificar) y **Act** (estandarizar o corregir y reiniciar).

Concepto	Qué es	Ejemplo
Criterio	La norma cualitativa de buena práctica	"Toda gestante ingresada llevará pulsera de identificación"
Indicador	La fórmula que mide el cumplimiento	(gestantes con pulsera / total ingresadas) × 100
Estándar	La meta numérica aceptable	100%

- Los estándares de seguridad vital o derechos se fijan en el **100%**; otros (dolor controlado), en el **80-90%**.
- Tipos de indicador de un programa: de **cobertura** (a cuántos llega), de **cumplimiento** o adherencia (p. ej., **número de pacientes que no siguen la dieta** en un programa de hipercolesterolemia), de eficacia y de efectividad.

> **TRAMPAS DE EXAMEN**
>
> ! "El 95% de los pacientes debe tener firmado el consentimiento" es un **estándar**, no un indicador.

B3. EFQM 2020, certificación y seguridad del paciente

- **EFQM 2020** (modelo de excelencia de la *European Foundation for Quality Management*, inspirado en el **círculo dorado de Sinek**): **3 bloques y 7 criterios** (antes 9).

Bloque	Criterios
Dirección (por qué)	1. Propósito, visión y estrategia · 2. Cultura y liderazgo
Ejecución (cómo)	3. Implicar a los grupos de interés · 4. Crear valor sostenible · 5. Gestionar el funcionamiento y la transformación
Resultados (qué)	6. **Percepción** de los grupos de interés (PREMs, clima, burnout) · 7. **Rendimiento** estratégico y operativo (mortalidad, IAAS, estancia)

- Herramienta **REDER** (en inglés RADAR): Resultados, Enfoque, Despliegue, Evaluación y Revisión.
- **ISO 9001**: certificación de procesos y documentación (origen industrial). **Joint Commission International**: **acreditación** sanitaria centrada en el paciente y en las metas de seguridad (identificación, comunicación estructurada SBAR, medicamentos de alto riesgo, cirugía segura, caídas). **UNE 179003**: gestión de riesgos para la seguridad del paciente.
- **"To Err is Human" (1999)**. **ENEAS**: eventos adversos en torno al **9%** de los ingresados, **más del 42% evitables** (en Atención Primaria, estudio **APEAS**); causas: medicación, infecciones y cuidados.
- **Estrategia de Seguridad del Paciente del SNS**: cultura de seguridad justa, prácticas seguras, **notificación voluntaria, confidencial, anónima y no punitiva** (**SiNASP**) e implicación del paciente.
- **Errores de medicación**: bombas de infusión inteligentes, administración con código de barras, los "cinco correctos" (paciente, medicamento, dosis, vía y momento) y zona de preparación tranquila ("no molestar"). Hay que **animar a notificar** los errores, nunca desanimar.
- **AMFE** = **proactivo** (antes del fallo, en procesos nuevos). **Análisis causa raíz** = **reactivo** (tras un evento centinela).

Proyectos Zero (paquetes de medidas)

Proyecto	Medidas clave
Bacteriemia Zero (CVC)	Higiene de manos; máximas barreras estériles; **clorhexidina alcohólica > 0,5%** (2%); **preferir subclavia, evitar femoral**; retirar vías innecesarias

Proyecto	Medidas clave
Neumonía Zero (NAV)	Cabecero a **30-45°**; higiene bucal con clorhexidina 0,12-0,2%; **neumotaponamiento 20-30 cmH_2O**; no cambiar tubuladuras de rutina; interrupción diaria de la sedación
ITU Zero	Indicación estricta y asepsia; **sistema cerrado**; buena fijación; retirada precoz
Resistencia Zero	Optimizar antibióticos; higiene de manos; precauciones de contacto; descolonización
Flebitis Zero	Menor calibre posible; clorhexidina; apósito transparente; **cambiar el catéter solo por indicación clínica** (no cada 72-96 h)

B4. Atención basada en valor, programas de calidad y PBE

- **Value-Based Healthcare** (**Porter y Teisberg**, Harvard): **Valor = resultados en salud / costes del ciclo completo**. **Unidades de Práctica Integrada** organizadas por condición clínica.
- **PROMs** (resultados de salud que reporta el paciente: dolor, función, calidad de vida; **SF-36, EQ-5D, WOMAC**) frente a **PREMs** (experiencia: trato, esperas, información; **NPS** o *Net Promoter Score*, **HCAHPS**). Consorcio internacional **ICHOM**. En España, **IEXPAC** (experiencia del paciente crónico): **11 ítems** + 4 opcionales.
- **Programa de calidad en una unidad**: 1) identificar el problema (**Pareto 80/20**; **Ishikawa** o espina de pescado: métodos, mano de obra, materiales, medio); 2) objetivos **SMART** (específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con plazo); 3) diseñar la intervención (procedimientos, vías clínicas); 4) ejecutar, formar y monitorizar.
- **GRADE** (2000): calidad **alta, moderada, baja o muy baja** (símbolos ⊕); ECA parten de alta y observacionales de baja; recomendación **fuerte** (aplicar a casi todos; puede ser indicador obligatorio) o **débil** (decisión compartida).
- **PBE** (McMaster; **Sackett, 1996**): evidencia + experiencia + valores del paciente. 5 A con **PICO** y la **pirámide 6S de Haynes** (empezar por la cúspide: sistemas, sumarios como UpToDate, sinopsis, síntesis, sinopsis de estudios y estudios).

TRAMPAS DE EXAMEN

! El dolor 2/10 tras una prótesis que reporta el paciente es un **PROM**, no un PREM.

! Letras y números (A, 1++) **no** son GRADE.

Otras preguntas del test de este tema

Estas preguntas del EIR caen en el test de este tema aunque su materia es de otros apartados del programa (Ley General de Sanidad y Ley 16/2003, temas 1 y 4).

- **Ley General de Sanidad, art. 6**: las administraciones sanitarias se orientan a la **promoción de la salud**, a **promover el interés individual, familiar y social por la salud mediante la educación sanitaria**, a la **prevención** de las enfermedades (y no solo a su curación), a la asistencia en todos los casos de pérdida de salud y a la rehabilitación y reinserción social.
- **Uso tutelado (art. 22 Ley 16/2003)**: usar una técnica, tecnología o procedimiento, con un diseño de investigación, en centros autorizados y con consentimiento informado, para establecer su **seguridad, eficacia, efectividad o eficiencia antes de decidir si se incluye en la cartera de servicios** del SNS.
- **Extranjeros sin residencia legal (art. 3 ter Ley 16/2003)**: tienen derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria **en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española**, sin póliza privada y no solo en urgencias.